

Información Paciente

Nombre : Edita Calabrano Oliva
Edad : 62a 5m 16d
Dirección : Las Cepas 1211 Villa Tocornal

Rut : 7.862.123-0
Fecha Nacto: 15/06/1960
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9833471
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5035 9314

N° Epicrisis
332220

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 02/11/2022 10:49

Días Estadía: 29

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 01/12/2022 13:15

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Síndrome Nefrítico Rápidamente Progresivo Con Glomerulonefritis

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS 01/12/2022

Nombre: Edita Calabrano Oliva
RUT: 7.862.123-0
Edad: 62 años
FI CASR: 02/11/2022
FI UTIM: 04/11/2022
FI Sala: 08/11/2022
Reingresa a UTI: 21/11/22
Fecha fallecimiento: 01/12/22

Antecedentes

- Mórbidos: HTA, DM2 NIR, hipotiroidismo.
- Quirúrgicos: Ninguno.
- Fármacos: Levotiroxina 100 mcg, Jardiance, Losartán 50 mg, Atorvastatina 10 mg, Hidroclorotiazida 50 mg.
- Alergias: Niega.
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), drogas (-)
- Inmunizaciones: COVID e Influenza.
- Hospitalizaciones: (-)

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 2 semanas de hematuria, asociada a dolor hipogástrico de carácter sordo, con dolor lumbar sin gatillantes, tenesmo vesical, cefalea intermitente, náuseas y 3 episodios de vómitos. Evaluada en APS el 26/10, se realizó exámenes donde destaca Crea 3.34, glicemia 172, OC con GR +++, nitritos -, glucosuria +++, Se indicó manejo sintomático con analgésicos, sin respuesta. Por persistencia de los síntomas, con aumento en la intensidad de hematuria y náuseas, acude a urgencias. Al ingreso se describe en buenas condiciones, hemodinamia estable, afebril, sin req. O2, edematosa, se instala foley con salida de orina de tinte hemático. Al laboratorio de ingreso destaca ELP 126/4.64/95, pH 7.26, CO2 35, BIC 15.7, Crea 8.2, BUN 88, SO con GB 5 - 10, GR 40 - 45, bacterias escasas. En el estudio con imágenes: Ecografía renal informa signos de nefropatía médica bilateral, PielotAC sin litiasis, con signos de ureteritis bilateral. Ecografía abdominal informa colesterosis vesicular, sin otros hallazgos. Evoluciona en UEA con deterioro de función

Fecha Epicrisis :

renal hasta Crea 10.87 y BUN 114, por lo que se decide ingreso a UTIM con los siguientes diagnósticos:

- Insuficiencia renal aguda sobre crónica
- Acidosis metabólica
- Hematuria
- Ureteritis bilateral
- Antecedentes: HTA, DM2, hipotiroidismo.

En UTI se indica AB empírico y se inicia terapia dialítica.

Posterior a esto se traslada a sala de medicina para continuar con estudio de falla renal

Durante estancia en Sala de medicina básica se detecta hematuria de origen glomerular por lo que se solicita estudios detectando ANCA P MPO (+) indicando así Metilprednisolona 3g y continuar con prednisona en dosis alta que aún recibe.

A pesar de esto mantiene anuria y por sospecha de hemorragia alveolar se indica Ciclofosfamida la cual recibe el 19/11/22. Se solicita traslado a UTI porque la paciente presenta signos de congestión pulmonar e HTA. Con posterior evolución tórpida requiriendo IOT y VMI con traslado a UPC para continuar manejo.

Evolución en UPC

- Hemodinámico: A su ingreso a UPC con requerimientos de DVA a dosis bajas en contexto de sedación. Posteriormente en contexto de shock séptico desarrollado desde el martes 29/11 con DVA al alza hasta NAD a 0.85 y AD a 0.4 ug/kg/min. Por shock séptico refractario se indicó HFAV durante 24 horas sin respuesta.

- Renal/Reumatológico: En falla renal anúrica por GNRP (anti mb basal (+)). Alcanzó a recibir 4 sesiones de plasmaféresis sin respuesta clínica y HD con UFA para manejar sobrecarga de volumen.

Sin antecedente de ERC, ingresa cursando AKI KDIGO 3, requiriendo TRR desde el 05/11. Estudio:

- Eco renal con signos de cronicidad.
- SOC que destaca GR dismórficos (sin número), sin cilindros ni acantocitos.
- ANCAp +, ANA (-), FR (-), complemento normal, sin baja de peso, sin lesiones purpúricas, sin síntomas respiratorios.
- Anti MB 182.5 (positivo moderado a fuerte).
- antiPR2L: pendiente.

Completó pulsos de metilprednisolona 1 gr por 3 días (FI 12/11), luego prednisona 60 mg/día y actualmente está con HCT 50 mg c/6 hr (se traslapó PDN a HCT para aporte de mineralocorticoides en dosis de stress). Sin recuperación de falla renal. Ante posible hemorragia alveolar (ya descartada) además se indicó Ciclofosfamida 1era dosis el 19/11/22.

Infeccioso: Recibió tratamiento ATB con ampicilina para cobertura de E. faecalis en orina desde el 21/11, posteriormente desarrolló NAVM por KPN BLEE en paciente inmunosuprimido, respondiendo con leucopenia y shock séptico refractario.

Paciente fallece acompañada de familiares el 01/12/2022 a las 13:15 hr.

Diagnostico:

Shock séptico refractario

Falla orgánica múltipe

Neumonía asociada a ventilación mecánica

GNRP en tratamiento, oligúrica a anúrica reciente.

- Obs Vasculitis ANCA p(+) MPO+

Ureteritis bilateral

HipoNa leve asintomática

ITU vs bacteriuria por E faecalis (+) (UC 08/11)

Antecedentes: HTA, DM2, hipotiroidismo.

Diagnóstico de Egreso

En resumen de egreso -

Fecha Epicrisis :



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Condición de Egreso Fallecido

Fallecida.

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fallecida.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Tomás Lahera Frohmann

Médico Tratante (Staff)